EONU

함께 오지 못해도,
이야기는 함께.

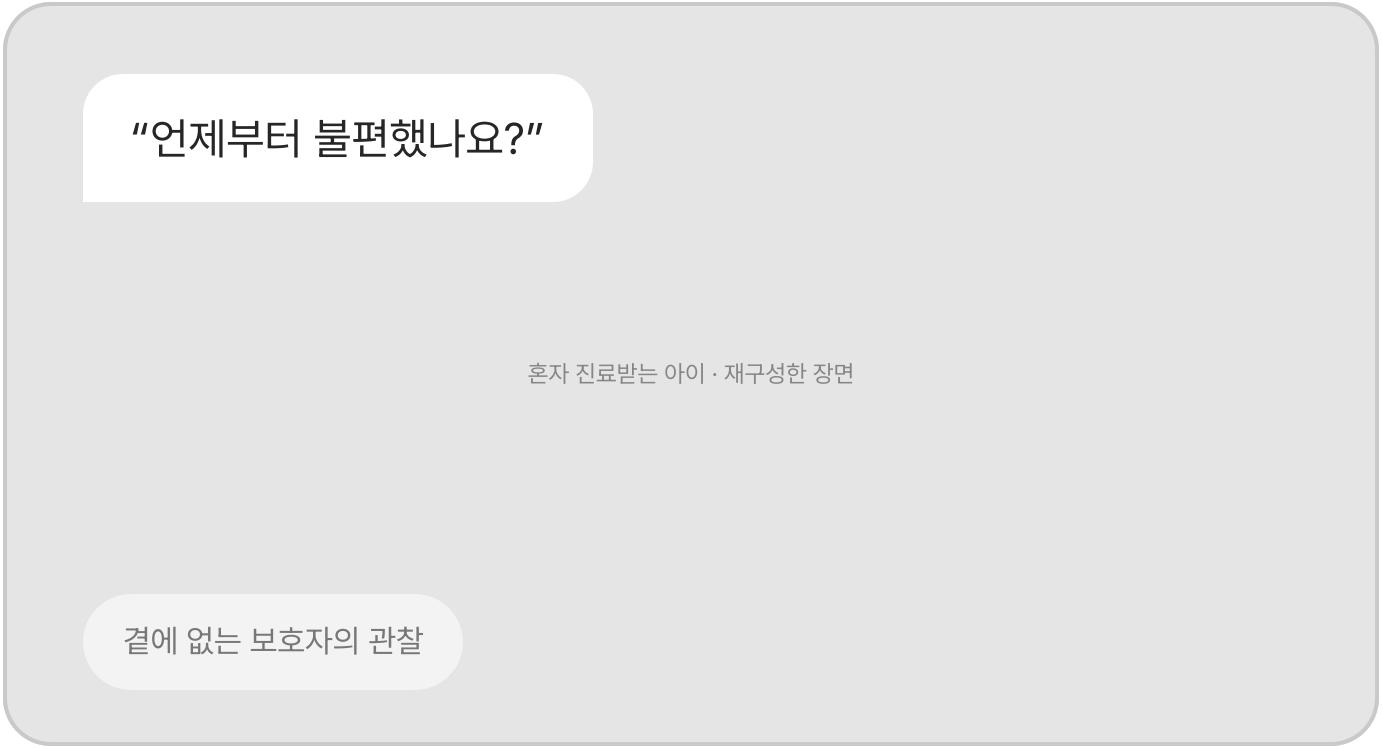
환자 · 보호자 · 의료진의
AI 소통을 잇는 이어온유





환자는 왔지만, 이야기는 오지 못했습니다.

혼자 진료받는 아이와, 곁에 있지 못한 보호자.



필요한 이야기도 함께 와야 합니다.

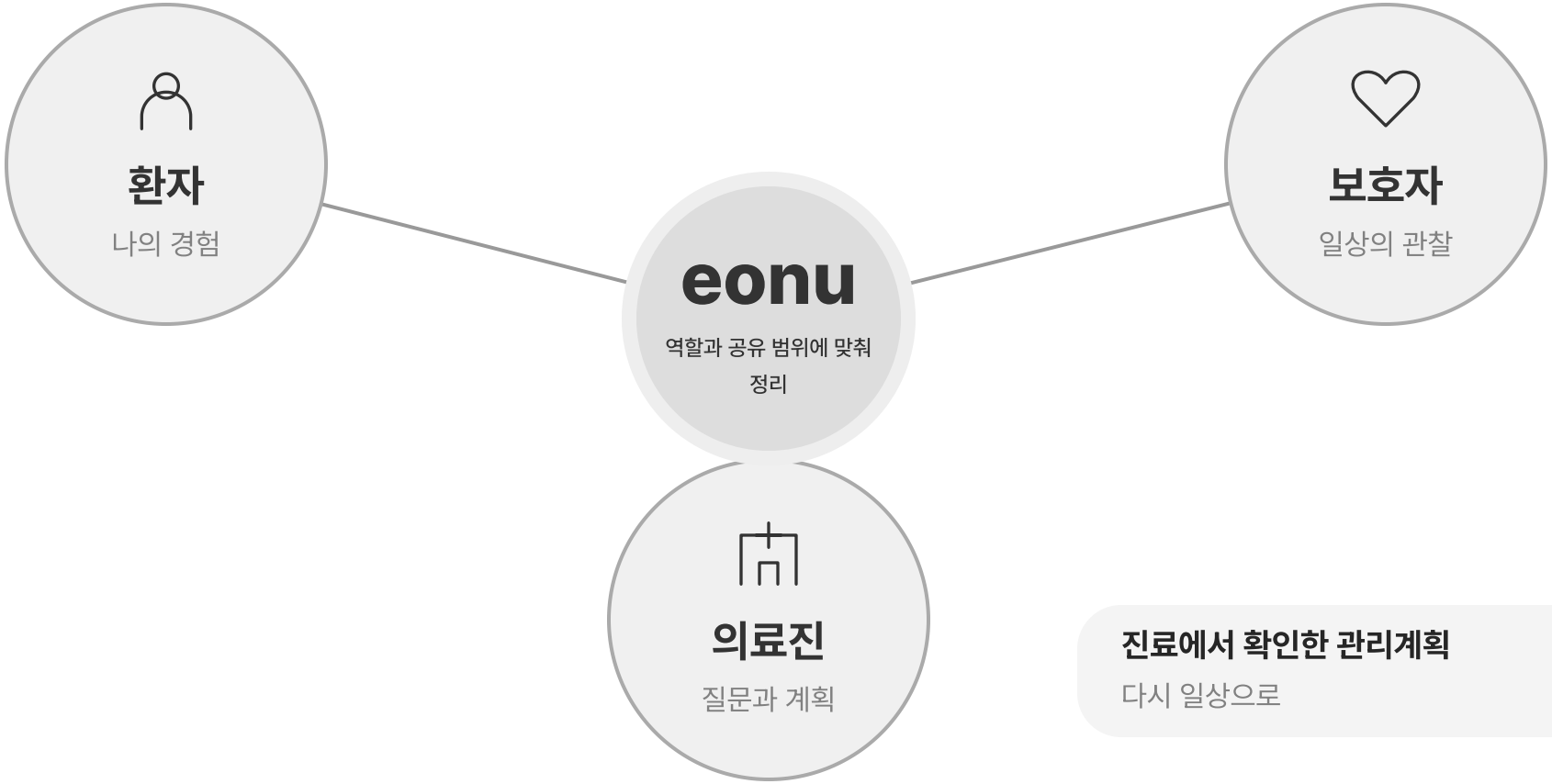
환자 경험을 설명하기 어렵고

보호자 관찰을 전달하지 못하고

의료진 필요한 맥락을 확인해야 합니다

세 사람의 이야기, 하나의 흐름으로.

환자의 경험 · 보호자의 관찰 · 의료진의 질문과 계획



진료에서 확인한 관리계획
다시 일상으로

서비스가 지향하는 연결 구조

환자의 걱정이, 병원의 상담 기회로.

의료진이 계속 참여할 세 가지 이유. 먼저 수익 기여 가능성을 검증합니다.

01

진료 효율

확인할 내용을
미리 준비

02

임상적 유용성

진료에 필요한
일상의 정보

03 · 초기 검증

수익 기여

걱정에서 시작하는
자발적 상담

미해결 걱정 → 관련 서비스 정보 비급여 포함 → **환자가 상담 선택**

병원이 묻고, 일상에서 답합니다.

질문·서비스 정보·관리 안내를 먼저 설정합니다.

병원 설정 설명용 제품 UI

다음 진료에 필요한 질문부터.

01	**확인할 질문**	최근 수면은 어땠나요?
02	**서비스 정보**	병원이 제공한 안내
03	**진료 후 관리**	일상에서 확인할 계획

의료진의 기준으로 설정

→

병원 안내 QR

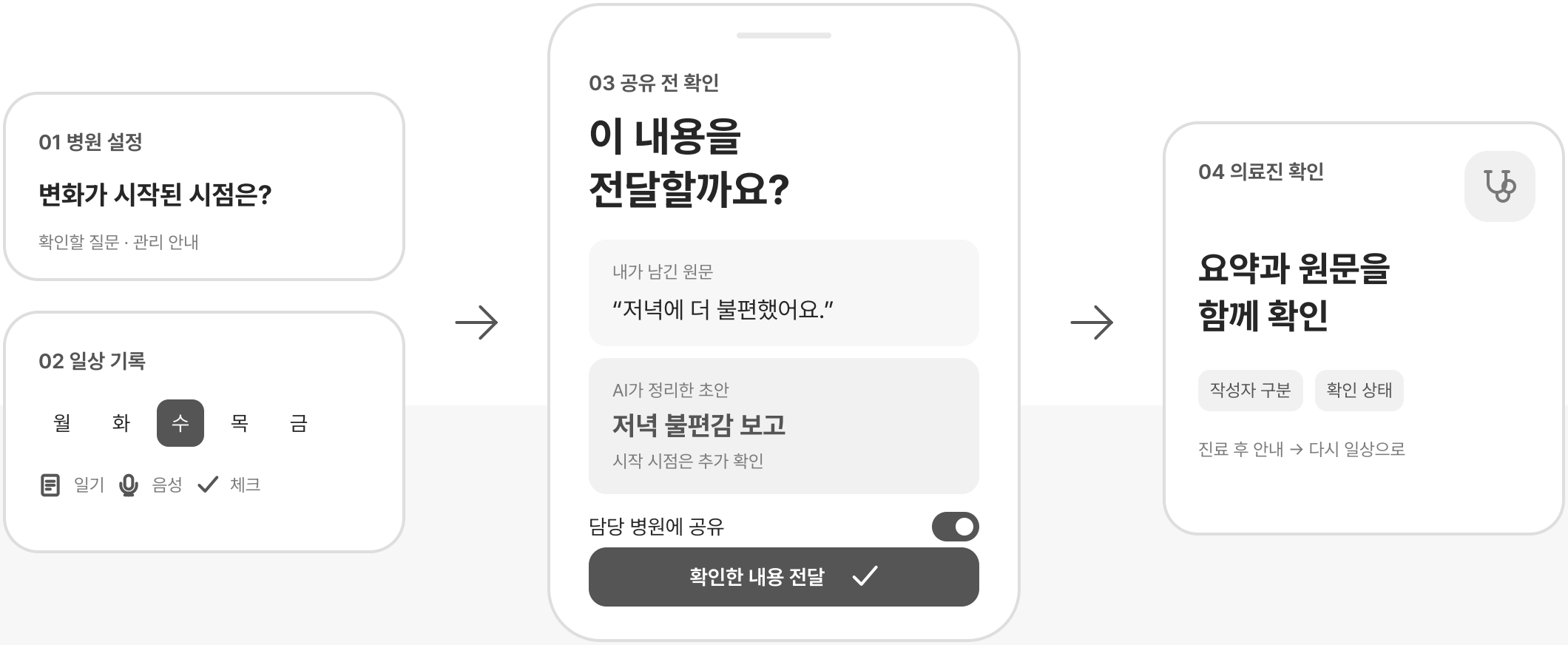


병원과 연결된 화면으로 입장

설명용 제품 구조 · 실제 접속 QR 아님

기록은 편하게. 전달은 확인하고.

병원 설정 → 일상 기록 → 공유 전 확인 → 의료진 확인



첫 매출의 출발점은 병원 라이선스.

일차의료기관에서 유료 도입을 검증하고, 다음 고객으로 넓힙니다.

첫 매출 가설

B2B

일차의료기관
소프트웨어 라이선스

첫 병원군 · 가격 선정 및 검증 중

01 **가상 사례 검토**

02 **범위가 정해진 제한 실증**

03 **유료 제안 → 계약**

B2B2C 추가 유료 가치 확인 후 확장

B2G 실제 구매기관 · 예산 · 계약을 확인하는 별도 경로

연구지원금 · 민간 봉사활동과 구분

큰 시장에서, 먼저 살 고객을 좁힙니다.

현재 판매할 소프트웨어를 기준으로 TAM · SAM · SOM을 구분합니다.



현재의 핵심 · B2B

기관 수 × 연간 라이선스

매출 상한과 실제 확보 목표를 분리

B2B2C	이용자 × 유료 전환율 × 연간 이용액
B2G	구매사업 수 × 계약 단가

중복 계약 · 연구지원금 · 미래 기기 매출 제외

시장 범위 개념도 · 면적은 금액에 비례하지 않음 · 입력값 미확정

일상 기록에서, 연결된 건강 정보로.

병원 도입 검증 이후, 정보의 임상적 유용성과 입력 부담을 확인합니다.



현장 피드백을, 첫 도입으로.

질문과 템플릿, 제품에 반영할 운영 경험을 모으고 있습니다.

현재 자료에 기재

전문의 피드백

정신과 전문의의 지속적 피드백

자문·협의 범위 확인 필요

현재 접점

연구기관 접점

도헌디지털의료혁신연구소

협의 상태와 범위 확인 필요

참여 확정 기재

청년 우울증 봉사

관련 자선사업 프로젝트 참여

공식 제휴·실증·계약과 구분

다음에는
도입의 증거로.

의료진 실제 활용 | 전체 업무 부담 | 반복 사용 | 구매 의사

질문 · 정보 템플릿 · 운영 경험으로 축적합니다.

현재 접점은 공식 제휴·실증·유료 계약과 구분

1억 원, 첫 유료 모델을 향한 실행 자금.

의료·AI 이해를 바탕으로 직접 기획하고, 개발하고, 수정합니다.



기획 → 개발 → 수정

의료 · AI 이해를 바탕으로 직접 실행

사용계획 총액

1억 원

제품	보안	실증	고객 확보	운영

첫 유료 모델 검증

소개 · 직접 접촉 → 방문 데모 → 파일럿

세부 배분 · 기간 · 실증 및 유료 고객 목표 · CAC 확정 전

EONU

환자에게 필요한 연결.
병원도 계속 쓸 이유.

세 사람의 안심을 잇고,
첫 유료 모델의 가치를 검증합니다.

서비스 브랜드 이미지

